



Ministério da Saúde

Urgencia Nº: XX Data Urg.: xx-xx-xxxx xx:xx:xx
Proc.: XXXX Identificação N. Utente: XXXX
Nome: XXX
Data Nasc.: XX/XX/XXXX (XX Anos) Prof XXXX Sexo: XXX
Morada: XXXX
Localidade: XXXX Telefone: XXXX

Médico Família

Centro de Saúde: XXXXX
Médico: XXXXXX

Outros Dados

Causa : XXXXXX Proveniência: XXXXXx
Subsistema: XXXXXX
Observações: XXXX

Triagem

Data / Hora da Triagem: XXXXX
Discriminador: xxxxx

Fluxograma : XXXX

Prioridade Clínica

Temperatura: Dor: XX

Glasgow: XXXXX

PEFR: Freq. Resp.: PA: /

Glicémia: Corpos cetónicos: Freq. card.: Ritmo de pulso:

Oxi. per.:

Mobilidade: XXXXXx

Especialidade: XXXXX Grupo: XXXXX Sala: XXXX

Queixa: XXXXX

Justificação Via Verde:

Triador: XXXXXXXX Nº. Mecanográfico: XXXX Ass.: _

Observações Médicas

22-Out-2025 16:42:00 Dr(a). Miguel Andrade (HUC-URG_ORTOPEDIA)

Homem, 71 anos, recorre por queda accidental no domicílio cerca das 14h00, por tropeção em tapete, com mecanismo de queda para a frente e apoio directo sobre mão/punho D. Nega traumatismo cranioencefálico, perda de conhecimento, lipotímia, dor cervical, dor torácica ou outra queixa traumática. Dor no punho D, predominantemente dorsal/radial, agravada pela mobilização e preensão. Edema ligeiro local. Sem ferida, hemorragia ou parestesias distais.

AP: DM2, HTA, DPOC moderada; adenocarcinoma próstata submetido a prostatectomia radical em 2022, sob hormonoterapia/vigilância. Ex-fumador. Alergia a contraste iodado, urticária ligeira prévia. MH: bicalutamida 50 mg id, metformina 1000 mg 2id, empagliflozina 10 mg id, perindopril 5 mg id, tiotrópio inalado 18 mcg id, salbutamol SOS.

EO: consciente, colaborante, orientado, GCS 15. Estado geral conservado. TA 146/78 mmHg, FC 82 bpm, FR 18 cpm, SpO2 96% AA, T 36,4°C. Sem sinais de trauma craniofacial. Coluna cervical sem dor à palpação, mobilidade indolor. Membro superior D: ombro, braço, cotovelo e antebraço sem dor, deformidade ou limitação funcional. Punho D c/ discreto edema dorsorradial, sem equimose exuberante, sem deformidade evidente. Dor à palpação da região radiocárpica e dor à mobilização activa/passiva, sobretudo extensão e desvio radial. Sem dor selectiva marcada na tabaqueira anatómica; sem instabilidade clínica. Dedos c/ mobilidade activa mantida, preensão condicionada por dor. Pulsos radial e cubital palpáveis, perfusão distal mantida, TEC <2 seg. Sensibilidade e força distal preservadas nos territórios mediano, radial e cubital. Sem défice neurovascular.

Rx punho D sem traço de fractura aguda ou luxação. Alinhamento radiocárpico e carpometacárpico mantido. Sem alterações traumáticas ósseas evidentes. Discretas alterações degenerativas radiocárpicas/intercarpais, já conhecidas. Quadro compatível c/ contusão/entorse ligeira do punho D pós-traumática.

Feita analgesia c/ paracetamol, c/ melhoria parcial da dor. Aplicada imobilização ligeira c/ ligadura elástica/ortótese de punho, mantendo perfusão e sensibilidade distal preservadas após procedimento. Orientado para gelo local 15-20 min, 3-4x/dia nas primeiras 48h, elevação do membro e repouso relativo; evitar cargas, movimentos repetitivos e apoio sobre a mão D. Pode manter paracetamol SOS. Reavaliação por MF/Ortopedia se dor persistente >5-7 dias. Recorrer de imediato se dor crescente, edema importante, alteração de cor/temperatura dos dedos, parestesias, diminuição de força ou incapacidade funcional.

Notas de Enfermagem

16h18 – Admitido deambulante, acompanhado por familiar. Dor referida 5/10 no punho D. Sem queixas adicionais. Sinais vitais colhidos: TA 146/78 mmHg, FC 82 bpm, SpO2 96% em ar ambiente, T 36,4°C.

17h25 – Após analgesia e imobilização, dor 2-3/10 em repouso. Extremidade D quente, rosada, pulsos presentes, sensibilidade conservada. Alta após esclarecimento de indicações e sinais de alarme.

Diagnósticos

(S63.5) - Entorse do punho direito

(M25.53) - Dor no punho direito pós-traumática

(W01) - Queda accidental ao mesmo nível no domicílio

Medicação

Data Início | Data Fim | Data da última toma | Designação do Fármaco

22/10/2025 16:55 | 22/10/2025 16:55 | 22/10/2025 16:55 | Paracetamol 1000 mg PO, toma única

MCDT Requisitados / Procedimentos Efectuados

M10865 – RX PUNHO DIREITO, 2 INCIDÊNCIAS (AP e perfil): mineralização óssea preservada. Sem evidência de traço de fractura aguda do rádio distal, cúbito distal ou ossos

do carpo. Sem luxação ou subluxação. Alinhamento radiocárpico, intercarpal e carpometacárpico mantido. Discreto aumento de partes moles periarticular dorsal. Alterações degenerativas ligeiras radiocárpicas/intercarpais, sem agravamento traumático identificável.

P00321 – Imobilização funcional ligeira do punho direito com ligadura elástica/ortótese.

Destino do Doente

Data: 22/10/2025 17:38

Destino: Alta para domicílio, autónomo, acompanhado.

Médico: Dr(a). Miguel Andrade